

फिस्टुला — जेनिटोयूरिनरी और रेक्टोवेजाइनल

WARWIKI

रोगी जानकारी · दो अंगों के बीच असामान्य रास्ता जिससे मूत्र, गैस या मल रिसता है

फिस्टुला दो अंगों के बीच एक असामान्य सुरंग होती है जो नहीं होनी चाहिए। श्रोणि में यह मूत्राशय (या मूत्रवाहिनी/मूत्रमार्ग) और योनि के बीच बन सकती है — जिससे लगातार मूत्र रिसता रहता है — या मलाशय और योनि के बीच — जिससे गैस या मल योनि से निकलता है। फिस्टुला खुद से ठीक नहीं होती, लेकिन इसकी मरम्मत की जा सकती है।

इस स्थिति के बारे में

- **जेनिटोयूरिनरी फिस्टुला** (जैसे vesicovaginal) — योनि से लगातार, बेकाबू मूत्र रिसाव, दिन और रात।
- **रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला** — योनि से गैस या मल निकलना, बार-बार संक्रमण और जलन।

ये लक्षण परेशान करने वाले हो सकते हैं — लेकिन यह एक शारीरिक समस्या है जिसका समाधान है; इसमें आपकी कोई गलती नहीं।

कारण

- **पेल्विक या स्त्री रोग संबंधी सर्जरी** (जैसे hysterectomy) — कई देशों में सबसे आम कारण
- **प्रसव** — विशेष रूप से लंबे, अवरुद्ध प्रसव के कारण (विश्व स्तर पर प्रमुख कारण)
- **रेडिएशन**, सूजन संबंधी आँत की बीमारी, संक्रमण, या (कम बार) कैंसर

शब्दों को समझें

फिस्टुला

दो अंगों को जोड़ने वाली असामान्य सुरंग।

Vesicovaginal

मूत्राशय और योनि के बीच फिस्टुला।

Rectovaginal

मलाशय और योनि के बीच फिस्टुला।

Dye test

रिसाव का पता लगाने के लिए मूत्राशय/मलाशय में रंगीन तरल डालना।

Cystoscopy

मूत्राशय के अंदर camera से देखना।

Martius flap

मरम्मत को मजबूत करने के लिए ऊतक की पट्टी।

Diversion

ठीक होने के दौरान मूत्र या मल को अस्थायी रूप से दूसरे रास्ते भेजना।

क्या इसे ठीक किया जा सकता है? हाँ — अधिकांश फिस्टुला की मरम्मत हो सकती है और कई लोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। कभी-कभी छोटी, ताज़ी फिस्टुला कैथेटर से खुद बंद हो जाती है, लेकिन अधिकांश को नियोजित सर्जरी की आवश्यकता होती है। समय महत्वपूर्ण है: सर्जन अक्सर सूजन कम होने का इंतज़ार करते हैं।

जाँच कैसे होती है

- जाँच, अक्सर **dye test** से रिसाव का सटीक पता लगाना
- **Cystoscopy** और imaging से आकार, स्थान और कारण की जानकारी
- रेडिएशन प्रभाव, संक्रमण या IBD जैसी किसी अन्य स्थिति की जाँच

इलाज कैसे होता है

- 1 **सामान्य देखभाल** — छोटी, हाल की मूत्र फिस्टुला कुछ हफ्तों तक कैथेटर रखने से बंद हो सकती है।
- 2 **सर्जिकल मरम्मत** — योनि या पेट के रास्ते सुरंग को परतों में बंद करना।
- 3 **Tissue flap** — स्वस्थ ऊतक (जैसे Martius flap) से मरम्मत को मजबूत करना, खासकर रेडिएशन के बाद।
- 4 **अस्थायी diversion** — कुछ rectovaginal फिस्टुला में, ठीक होने के दौरान मल को अस्थायी रूप से दूसरे रास्ते भेजा जाता है।

ज़रूरी बातें

- मरम्मत की प्रतीक्षा में त्वचा की देखभाल करें और पैड उपयोग करें; आपकी टीम आराम में मदद करेगी।
- **रेडिएशन** के बाद मरम्मत जटिल होती है और आमतौर पर tissue flap की जरूरत होती है।
- कैथेटर हटाने से पहले **healing test** हो सकता है।

यदि आपको ये हों तो अपनी चिकित्सा टीम को बुलाएँ:

- बुखार या ठंड लगना, या पेल्विक दर्द बढ़ना
- संक्रमण के संकेत, या अधिक रक्तस्राव
- मरम्मत के बाद: कैथेटर से निकासी बंद हो, या रिसाव वापस आए

याद रखने योग्य तीन बातें

1. फिस्टुला एक असामान्य रास्ता है जिससे मूत्र रिसता है (जेनिटोर्यूरिनरी) या गैस/मल योनि से निकलता है (रेक्टोवेजाइनल)।
2. अधिकांश ठीक हो सकती हैं — कुछ छोटी कैथेटर से बंद होती हैं, पर अधिकांश को सर्जरी चाहिए, कभी-कभी tissue flap के साथ।
3. समय महत्वपूर्ण है; सूजन कम होने का इंतज़ार हो सकता है। मरम्मत के बाद बुखार, संक्रमण या रिसाव की सूचना दें।